

Guia de Revisão Express

Sufixos indispensáveis, gatilhos de prova, interações críticas de balcão/hospital e farmacocinética clínica acelerada.

Formato: Consulta Rápida & Resumo de Véspera

Objetivo: Fixação de Sufixos, Interações e Toxicidade

Público: Estudantes de Farmácia e Profissionais

01. DECODIFICADOR EXPRESSO DE NOMES (SUFIXOS CLÍNICOS)

SUFIXO / PREFIXO	CLASSE FARMACOLÓGICA	MECANISMO RESUMIDO	EXEMPLOS CLÁSSICOS
-pril	Inibidor da ECA (IECA)	Bloqueia conversão de Angio I em II; poupa bradicinina	Enalapril, Captopril, Ramipril
-sartana	Bloqueador do Receptor AT ₁ (BRA)	Bloqueio competitivo e seletivo no receptor de Angio II	Losartana, Valsartana, Candesartana
-olol	Betabloqueador (β)	Antagonismo adrenérgico β (reduz FC e débito cardíaco)	Atenolol, Propranolol, Metoprolol
-dipina	Bloq. Canais Cálcio (Dihidropiridínico)	Vasodilatação arterial periférica seletiva	Anlodipino, Nifedipino, Nicardipino
-statina	Inibidor da HMG-CoA Redutase	Inibe síntese hepática de colesterol celular	Atorvastatina, Rosuvastatina, Sinvastatina
-prazol	Inibidor da Bomba de Prótons (IBP)	Inativação covalente irreversível da H ⁺ /K ⁺ -ATPase gástrica	Omeprazol, Pantoprazol, Esomeprazol
-triptana	Agonista Seletivo 5-HT _{1B/1D}	Vasoconstrição de vasos cranianos na enxaqueca aguda	Sumatriptana, Naratriptana, Zolmitriptana
-gliflozina	Inibidor do Cotransportador SGLT2	Bloqueia reabsorção renal de glicose no túbulo proximal	Dapagliflozina, Empagliflozina
-gliptina	Inibidor da Enzima DPP-4	Prolonga a vida útil do GLP-1 endógeno (incretinas)	Sitagliptina, Vildagliptina, Linagliptina
-azol (Antifúngico)	Azólicos / Inibidores da 14-α desmetilase	Bloqueia a biossíntese de ergosterol na membrana fúngica	Fluconazol, Itraconazol, Cetoconazol

02. TOP INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS FATAIS / CRÍTICAS

ASSOCIAÇÃO DE FÁRMACOS	MECANISMO DO CONFLITO	DESFECHO CLÍNICO GRAVE	CONDUTA DO FARMACÊUTICO
Varfarina + AINEs (ex.: Ibuprofeno)	Sinergismo anti-hemostático + lesão erosiva da mucosa gástrica pelos AINEs.	Hemorragia GI Severa	Substituir analgésico por Paracetamol ou Dipirona em dose baixa.
Sildenafil + Nitratos (ex.: Isossorbida)	Inibição da PDE-5 + doação maciça de NO gerando acúmulo excessivo de GMPc.	Hipotensão Refratária / Choque	Associação contraindicada absoluta. Janela de pelo menos 24-48h.
ISRS + Tramadol / IMAO	Potencialização extrema da transmissão serotoninérgica central e periférica.	Síndrome Serotoninérgica	Hipertermia, mioclonias, rigidez e colapso autonômico. Evitar associação.
Enalapril + Espironolactona	Bloqueio conjunto de Angiotensina II e Aldosterona poupando eliminação de K ⁺ .	Hipercalemia Grave (Arritmia)	Monitoramento rigoroso de K ⁺ plasmático e ECG frequente.

ASSOCIAÇÃO DE FÁRMACOS	MECANISMO DO CONFLITO	DESFECHO CLÍNICO GRAVE	CONDUTA DO FARMACÊUTICO
Clarithromicina + Sinvastatina	Forte inibição da CYP3A4 pelo macrolídeo, multiplicando níveis da estatina.	Rabdomiólise / Lesão Renal	Suspender a estatina durante os dias de uso do antibiótico.

03. RESUMO RELÂMPAGO DE FARMACOCINÉTICA CLÍNICA

INDUTORES VS INIBIDORES CYP450 Indutores (Aumentam metabolismo → Falha terapêutica): Regra Mnemônica: CRAP GPS Carbamazepina, Rifampicina, Álcool crônico, Fenitoína, Griseofulvina, Fenobarbital, Erva-de-São-João. Inibidores (Diminuem metabolismo → Intoxicação): Clarithromicina, Cetoconazol/Fluconazol, Suco de Toranja (Grapefruit), Amiodarona, Cimetidina, Omeprazol.	ÍNDICE TERAPÊUTICO ESTREITO (MONITORAR!) Fármacos cuja dose terapêutica é extremamente próxima da dose tóxica: • Lítio: Monitorar litemia (0,6 a 1,2 mEq/L); risco renal e tremores. • Digoxina: Monitorar potássio (hipocalemia piora intoxicação). • Fenitoína: Cinética não linear (ordem zero em doses altas). • Aminoglicosídeos (Gentamicina): Ototoxicidade e nefrotoxicidade.
---	--

04. REGRAS DE OURO NA DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA

MEDICAMENTO	ORIENTAÇÃO OBRIGATÓRIA AO PACIENTE	JUSTIFICATIVA TÉCNICA FARMACÊUTICA
Alendronato de Sódio (Bifosfonato)	Tomar em jejum com copo cheio de água pura; não deitar por 30 minutos.	Prevenção de esofagite erosiva grave e ulceração perfurante por refluxo do comprimido.
Tetraciclinas / Quinolonas	Não ingerir concomitantemente com leite, antiácidos, cálcio, ferro ou magnésio.	Formação de quelatos insolúveis com cátions polivalentes (↓ absorção a quase zero).
Metronidazol	Abstinência rigorosa de qualquer bebida alcoólica durante o uso e até 48h após.	Efeito dissulfiram (antabuse): bloqueio da aldeído desidrogenase → vômito, taquicardia e rubor.
Corticoides Orais Crônicos	Nunca interromper o tratamento de forma abrupta; realizar desmame gradativo.	Supressão do eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal) e risco de insuficiência adrenal aguda.

Material Didático Integrante do Combo de Bônus Farmacologia Clínica Descomplicada

Uso exclusivo para revisão e fixação prática de estudantes de Farmácia. Conteúdo esquematizado segundo diretrizes farmacêuticas atuais.